

	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.77/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep	
Pengertian	Kewaspadaan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi rutin dan harus diterapkan terhadap semua pasien di semua fasilitas kesehatan		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan kewaspadaan standar		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	1. Kebersihan tangan a. Hindari menyentuh dipermukaan disekitar pasien agar tangan terhindar kontaminasi pathogen dari dan kepermukaan b. Bila tangan tampak kotor, mengandung bahan berprotein, cairan tubuh, cuci tangan dengan sabun biasa/ antimikroba denbgan air mengalir c. Bila tangan tidak tampak kotor dekontaminasi tangan dengan menggunakan alcohol handruf d. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan 5 moment WHO : 1) Sebelum kontak dengan pasien 2) Sebelum melakukan prosedur / tindakan aseptic 3) Setelah kontak dengan pasien 4) Setelah terpapar atau kontak dengan cairan tubuh pasien 5) Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. 2. Alat Pelindung Diri (APD) : sarung tangan, Masker, Goggle (kaca mata pelindung), pelindung wajah, gaun a. Pakai bila mungkin terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi, ekresi dan bahan terkontaminasi, mucus membrane dan kulit yang tidak utuh, kulit utuh yangberpotensi terkontaminasi b. Pakai sesuai dengan ukuran tangan dan jenis tindakan c. Pakai sarung tangan sekali pakai saat merawat pasien langsung d. Pakai sarung tangan sekali pakai atau pakai ulang untuk membersihkan lingkungan e. Lepaskan sarung tangan segera setelah selesai, sebelum menyentuh benda dan permukaan yang tidak terkontaminasi, sebelum beralih ke pasien yang lain f. Jangan memakai sarung tangan 1 pasang untuk pasien yang berbeda g. Ganntilah sarung tangan bila tangan berpindah dari area tubuh yang terkontaminasi ke area tubuh yang bersih h. Cuci tangan tangan setelah melepas sarung tangan i. Pakailah untuk melindungi kunjungtiva, mucus merman mata, hidung, mulut, selama melaksanakan prosedur dan aktivitas perawatan pasien yang berisiko terjadi cipratan/ semprotan darah, cairan tubuh, sekresi, ekresi.		

	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.77/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 4
	j. Pilih sesuai dengan tindakan yang akan dikerjakan k. Masker bedah dapat dipakai secara umum untuk petugas rumah sakit untuk mencegah transmisi melalui partikel besar dari droplet saat kontak erat (<3 m) dari pasien saat batuk/ bersin l. Pakailah selama tindakan yang menimbulkan aerosol walaupun pada pasien tidak diduga infeksi m. Kenakan gaun (bersih, tidak steril) untuk melindungi kulit, mencegah baju menjadi kotor, kulit terkontaminasi selama prosedur/ merawat pasien yang memungkinkan terjadinya percikan / semprotan cairan tubuh pasien n. Bila gaun tidak tembus cairan, perlu dilapisi apron tahan air o. Lepaskan gaun segera dan cucilah tangan untuk mencegah transmisi mikroba ke pasien lain dan lingkungan p. Kenakan gaun saat merawat pasien infeksi yang secara efidemokologik penting, lepaskan saat akan keluar ruang pasien q. Jangan memakai gaun pakai ulang walaupun untuk pasien yang sama r. Bukan indikasi pemakaian rutin masuk ke ruang risiko tinggi seperti ICU, NICU. 3. Peralatan perawatan pasien a. Buatlah aturan dan prosedur untuk menampung, transportasi, peralatan yang mungkin terkontaminasi darah atau cairan tubuh b. Lepaskan bahan organik dari peralatan kritikal dengan bahan pembersih c. Tangani peralatan yang terkena darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi dengan benar sehingga kulit dan mucus membrane terlindung, cegah baju terkontaminasi, cegah transfer mikroba ke pasien lain dan lingkungan. Pastikan peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksi telah dibersihkan dan tidak dipakai untuk pasien yang lain. Pastikan peralatan yang sekali pakai dibuang dan dihancurkan melalui cara yang benar dan peralatan yang dipakai ulang diproses secara benar d. Peralatan nonkritikal terkontaminasi didisinfeksi setelah pakai. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau disterilisasi. Peralatan kritikal harus didisinfeksi kemudian disterilkan e. Peralatan makan pasien dibersihkan dengan air panas dan sabun natural f. Bila tidak tampak kotor, lap permukaan peralatan yang besar (USG, X-Ray) setelah keluar ruangan isolasi g. Bersihkan dan disinfeksi yang benar peralatan terapi pernapasan terutama setelah dipakai pasien infeksi saluran napas h. Alat makan dicuci dalam alat pencuci otomatis atau manual dengan sabun natural tiap setelah makan. Benda disposable dibuang ke tempat sampah. 4. Pengendalian lingkungan a. Pastikan bahwa rumah sakit membuat dan melaksanakan prosedur rutin untuk pembersihan, disinfeksi permukaan lingkungan, tempat tidur, peralatan disamping tempat tidur dan pinggirannya permukaan yang sering tersentuh dan pastikan kegiatan ini dimonitor		

	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.77/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 3 / 4
	b. Tetapkan disinfeksi standard untuk menghalau pathogen dan menurunkan secara signifikan di permukaan terkontaminasi sehingga memutuskan rantai penularan penyakit c. Lakukan pembersihan sebelum didisinfeksi d. Ikuti aturan pabrik cairan disinfeksi, waktu kontak, dan cara mengencerannya e. Pembersihan permukaan horizontal sekitar pasien harus dilakukan secara rutin dan tiap pasien pulang f. Untuk mencegah aerosolisasi pathogen infeksi saluran napas, hindari penggunaan sapu. g. Ganti cairan pembersih, lap kain, kepala mop setelah dipakai h. Peralatan pembersihan harus dibersihkan, dikeringkan setiap kali setelah pakai i. Jangan fogging dengan didisinfektan, tidak terbukti mengendalikan infeksi dan berbahaya bagi petugas 5. Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen a. Penanganan, transfort dan proses linen yang terkena darah cairan tubuh, sekresi, ekresi dengan prosedur yang benar untuk mencegah kulit, mucus membrane terekspose dan terkontaminasi linen. b. Buang terlebih dahulu kotoran (missal: feces), letakkan linen dalam kantong linen c. Hindari menyortir linen di ruang perawatan pasien, jangan memanipulasi linen terkontaminasi untuk hindari kontaminasi untuk hindari kontaminasi terhadap udara, permukaan dan orang d. Kirim linen ke laundry sesuai alur pengiriman yang sudah diterapkan e. Pastikan kantong tidak bocor dan ikatan tidak lepas selama transformasi f. Petugas yang menangani linen harus menggunakan APD 6. Kesehatan karyawan/ perlindungan petugas kesehatan a. Berhati – hati saat bekerja untuk mencegah trauma saat menangani jarum, scalpel dan alat tajam lain yang dipakai setelah prosedur, saat membersihkan instrument dan saat membuang jarum b. Jangan melakukan recapping jarum yang sudah dipakai, memanipulasi jarum dengan tangan, menekuk jarum, mematahkan, melepas jarum dari spuit. c. Buang jarum, scapel, spuit dan peralatan tajam habis pakai kedalam wadah tahan tusukan sebelum dip roses ke incinerator d. Pakai mouthpiece, resusitasi atau peralatan resusitasi yang lain untuk mengganti metode resusitasi mulut ke mulut e. Jangan mengarahkan bagian tajam jarum ke bagian tubuh selain akan menyuntik 7. Penempatan pasien a. Tempatkan pasien yang potensial mengkontaminasi lingkungan atau yang tidak dapat diharapkan menjaga kebersihan atau control lingkungan kedalam ruang rawat yang terpisah b. Bila ruangan tidak memungkinkan konsultasikan kepada komite PPI c. Cara penempatan pasien sesuai jenis kewaspadaan terhadap transmisi infeksi 8. Hygiene pernafasan/ etika batuk		

	SPO KEWASPADAAN TRANSMISI		
	No. Dokumen 935.77/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 4 / 4
	a. Edukasi petugas akan pentingnya pengendalian dekresi respirasi untuk mencegah transmisi pathogen dalam droplet b. Beri poster pada pintu masuk dan tempat strategis bahwa pasien atau pengunjung dengan gejala klinis infeksi saluran napas harus menutup mulut dan hidung dengan tisu kemudian membuangnya dan mencuci tangan. c. Sediakan sabun, wastafel, alcohol handrub dan cara melakukan kebersihan tangan d. Anjurkan pasien dan penunggu dengan gejala klinis infeksi saluran napas menggunakan masker 9. Praktek menyuntik yang aman a. Pakai sarung tangan yang steril, sekali pakai, pada setiap suntikan untuk mencegah kontaminasi pada peralatan injeksi dan terapi b. Pastikan obat injeksi yang digunakan onedose 10. Praktek untuk lumbal pungsi a. Pemakaian masker pada iresi catheter atau injeksi suatu obat kedalam area spinal/ epidural melalui prosedur lumbal panksi, untuk mencegah transmisi droplet flora orafaring		
Unit Terkait	Unit Pelayanan Unit Penunjang Unit Umum Komite PPI		